

„Chia seed internal shower“: čo na tom je a čo nie z pohľadu medicíny

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 17.06.2026

Keď pacienti prídu do ambulancie, často si nesú konkrétnu otázku: „Pomohlo by mi pitie chia semienok na vyčistenie čriev?“ Trend „internal shower“ (ráno zjesť alebo zaliať chia semienka vodou, aby sa „vypláchol“ tráviaci systém) sa šíri online neuveriteľne rýchlo. Zároveň však existuje výrazný rozdiel medzi tým, čo je na chia nutrične pravdivé, a tým, čo trend sľubuje.

Čo je na chia semienkach reálne dobré

Chia semienka (*Salvia hispanica*) majú reálnu nutričnú hodnotu. V zdrojovom článku sa zdôrazňuje najmä:

- vysoký obsah vlákniny (2 polievkové lyžice približne 10 g vlákniny),
- omega-3 mastné kyseliny (alfa-linolénová),
- bielkoviny a minerály.

Keď sa chia zmieša s vodou, rozpustná vláknina vytvorí viskózný gél. Takýto mechanizmus môže:

- pridať objem do stolice,
- zjemniť konzistenciu,
- podporiť prechod črevným traktom.

Toto nie je marketing. Je to bežná fyziológia vlákniny.

Kde sa medicína a marketing rozchádzajú

Sľub „internal shower“ vychádza z predstavy, že organizmus má „upchaté“ alebo „znečistené“ črevo a treba ho pravidelne „vypláchnuť zvnútra“. Klinicky je potrebné pacientom povedať priamo: telo nevnímajte ako upchatý odtok. Detoxikačné procesy prebiehajú priebežne a bez pitia chia vody ich netreba „spúšťať“.

V zdrojovom materiáli sa zároveň uvádza jasná pointa:

- neexistuje peer-reviewed dôkaz, že chia seed water má efekt „čistenia“ čreva nad rámec toho, čo by poskytla bežná diétna vláknina.

Inými slovami: ak pacientovi pomôže, je to v prvom rade preto, že prijal vlákninu, nie preto, že by sa „vypláchol“ vnútorný systém.

Vláknina nie je pre všetkých rovnaká

Jedna z najdôležitejších klinických nuáns je typ vlákniny a tolerancia v črevách, najmä pri:

- zápche,
- syndróme dráždivého čreva (IBS),
- nadúvaní a krčoch.

V zdrojovom článku sa uvádza, že:

- **psyllium** má najsilnejšiu dôkaznú bázu pre zlepšenie frekvencie a konzistencie stolice pri chronickej zápche,
- **nerozpustné vlákniny** (napr. pšeničné otruby) môžu u niektorých pacientov zhoršiť nadúvanie a diskomfort pri IBS,
- chia obsahuje rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu, pričom primárne ide skôr o rozpustnú zložku, čo môže byť pre viacerých pacientov v poriadku, ale nie pre každého.

Praktický dôsledok: odporúčanie „len pridajte vlákninu“ bez špecifikácie a bez titrácie je zbytočné riziko. Najmä u pacientov s IBS môže viesť k horšej symptomatike.

Prečo môže chia trend pacientovi uškodiť

Podľa zdrojového materiálu typický scenár v praxi vyzerá takto:

- pacient začne nárazovo (napr. „z nuly na plnú dávku“),
- do približne 72 hodín môže dôjsť k výraznému nadúvaniu, kŕčom a paradoxne aj k zhoršeniu zápchy.

Dôvod je jednoduchý: črevný mikrobiom potrebuje čas prispôbiť sa zvýšenému prísunu fermentovateľného substrátu a náhle zvýšenie môže zmeniť plynatosť aj motilitu.

Ako to komunikovať pacientovi v ambulancii (konkrétne odporúčanie)

Ak pacient trvá na skúšaní, zmysluplný a bezpečnejší rámec vychádza z praktickej titrácie:

- začať **0,5 až 1 polievkovou lyžicou denne**,
- dávku zvyšovať **postupne v priebehu niekoľkých týždňov**,
- a najmä **zabezpečiť dostatočný príjem tekutín**.

Dôležitá praktická veta pre pacienta: vláknina bez tekutín je recept na zhoršenie a riziko zhoršenej pasáže.

Zároveň môžete využiť „preorientovanie“ na dôkazy:

- denný cieľ vlákniny sa v zdrojovom článku uvádza približne **25 až 35 g denne** z rôznych potravín,
- pri zápche má psyllium silnú oporu v štúdiách,
- ako doplnok v praxi môžu fungovať aj konkrétne potraviny (napr. slivky, kiwi, ovos),
- pohyb a režim sú podstatnou súčasťou motility.

Kedy nepokračovať v trende a riešiť príčinu

Zdrojový článok upozorňuje aj na druhú, klinicky veľmi dôležitú rovinu: ak pacient používa wellness trend na dlhšie trvajúce ťažkosti, môže oddialiť vyšetrenie.

Varovný signál je najmä:

- zápcha, ktorá pretrváva,
- potreba „social media fixu“ na symptomatický problém, ktorý trvá mesiace,
- príznaky, pri ktorých treba myslieť na liekovú príčinu, endokrinnú poruchu alebo funkčnú poruchu defekácie.

V takých situáciách treba riešiť etiologicky, nie iba zvyšovať vlákninu.

Osobitné poznámky pre nefrologických pacientov (CKD, dialýza)

Toto je bod, ktorý trend často ignoruje. Pri ochoreniach obličiek sa tekutinový režim môže líšiť podľa štádia a liečby. Preto:

- odporúčanie „zabezpečte dostatok tekutín“ treba pre nefrologických pacientov preložiť do reality ich **individuálneho tekutinového limitu**,
- pri dialýze je obzvlášť dôležité, aby pacient chia skúšal len v rámci odporúčaného režimu a po dohode s ošetrovateľským tímom,
- ak sa objaví zhoršenie nadúvania, kŕčov alebo pasáže stolice, trend treba zastaviť a prehodnotiť stratégiu zápchy.

Nejde o to, že chia „je zakázaná“, ale o to, že nefrologická starostlivosť často mení praktické detaily (najmä tekutiny), aby sa minimalizovalo riziko.

Zhrnutie

„Chia seed internal shower“ je typický príklad, kde:

- **nutričná hodnota chia je skutočná** (najmä vláknina),
- **sľub „vyčistenia čriev“ nie je podporený klinickými dôkazmi**, ktoré by išli nad rámec účinku vlákniny,

- náhle zvýšenie dávky môže zhoršiť symptómy,
- najlepšie funguje princíp individualizácie: postupná titrácia, dostatočná hydratácia podľa tolerance a pri potrebe aj voľba vlákniny s lepšou dôkaznou oporou (napr. psyllium).

Zdroj: Medscape, článok „Chia Seed Cleanse: Where Medicine and Marketing Part Ways“ (2026). [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=chia-seed-internal-shower-medicina-vs-marketing> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.